

ANAMNESE OBSTETRICALE

1. Objectifs :

- Déterminer le ou les motifs de consultations
- Faire décrire la symptomatologie fonctionnelle de la patiente
- Connaître les signes physiologiques et pathologiques de la grossesse
- Répertorier les antécédents personnels et familiaux

2. Anamnèse

Les pathologies obstétricales évoluent en fonction du terme ; l'anamnèse se fera en fonction.

La patiente peut aussi souffrir de pathologies non obstétricales ; il faudra faire une anamnèse par système selon la plainte de la patiente.

3. Motifs de consultations

- Contrôle de grossesse
- Symptômes précis

4. Symptomatologie fonctionnelle spécifique à chaque trimestre

- **1^{er} trimestre** :
 - Douleurs
 - Saignement
 - Pertes vaginales anormales
 - Nausées, vomissements
 - Troubles urinaires
- **2^e et 3^e trimestre** :
 - Mouvements fœtaux (dès 18-20 SA)
 - Contractions
 - Douleurs abdominales
 - Saignements
 - Pertes de liquide
 - Symptômes de prééclampsie (dès 20 SA)
 - Signes de début de travail

- **Post-partum :**

- Saignements
- Pertes vaginales anormales
- Douleurs mammaires, pathologies de l'allaitement
- Symptômes de prééclampsie (jusqu'à 10j post-partum)
- Douleurs abdominales
- Troubles périnéaux
- Dépression

5. Symptomatologie fonctionnelle obstétricale

- **Contractions/douleurs :**

- Localisation
- Irradiation
- Type de douleur et intensité (échelle de la douleur)
- Date d'apparition et évolution dans le temps
- Facteur déclenchant et circonstance d'apparition
- Facteurs aggravants ou soulageants
- Temporalité (durée), fréquence (pour les CU)
- Impact fonctionnel (limitation de certaines activités ?)

- **Pertes de sang :**

- Quantité (taille de la tache de sang, caillots associés)
- Aspect : sang frais, vieux sang
- Spontané, provoqué (suite à un rapport sexuel, un examen gynéco, ...)

- **Pertes de liquide amniotique/pertes vaginales :**

- Aspect : liquide clair transparent, pertes grumeleuses, ...
- Odeur
- Couleur
- Symptômes associés : démangeaisons, brûlures, douleurs abdominales, ...

- **Symptômes urinaires ou digestifs :**

- Urinaire : dysurie, pollakiurie, hématurie, douleurs lombaires
- Digestif : transit, rectorragies, nausées, vomissements, perte de poids
- Signes associés : brûlures vulvo-vaginales, douleurs abdominales, signes généraux (fièvre, frissons, fatigue, ganglions)
- Symptômes chez le partenaire

- **Symptômes de prééclampsie :**

- Céphalées
- Acouphènes
- Scotomes
- Barre épigastrique
- Oedèmes, prise pondérale rapide
- **Symptômes de cholestase :**
 - Prurit (surtout palmo-plantaire, nocturne)
 - Lésions de grattage
- **Allaitement :**
 - Douleurs, induration, rougeur, engorgement
 - Lésions mamelonnaires (crevasses, ...)

6. Antécédents

- Antécédents médicaux
 - Médicaments
 - Allergies
 - Tabac
 - Diabète, HTA, ...
- Antécédents chirurgicaux
 - Interventions (année, voie d'abord, type d'intervention)
- Antécédents gynécologiques et obstétricaux
 - Infections gynécologiques (HPV, Chlamydia, ...)
 - Gestité, parité, FCS, IVG, voie d'accouchement
 - Déchirure périnéale, EML, hémorragie du pp
 - Préciser l'année, l'âge gestationnel, le poids à la naissance de l'enfant
 - Rapports sexuels : partenaire régulier, multiples, dyspareunie
 - Dernier contrôle gynécologique
- Antécédents familiaux
 - Cancers (col, utérus, sein, digestif, autre)
 - Maladie thrombo-embolique
 - Diabète, HTA, ...

7. Grossesse actuelle

- Informations à avoir :
 - Terme de la grossesse (DDR ou terme US)
 - Echographies de dépistage : 1er trimestre avec calcul du risque de

trisomie et échographie morphologique

- Croissance fœtale si réalisée
- Sérologies de grossesse : CMV, rubéole, varicelle, hépatites B/C, syphilis, HIV
- Vaccins : grippe, coqueluche
- Groupe sanguin, injection de Rhophylac faite à quelle SA si rhésus négatif ou réalisation d'un groupe sanguin fœtal
- Dépistage du diabète
- Recherche du streptocoque du groupe B dès 35 SA ou avant si MAP
- Dernier bilan sanguin (FSS, ferritine)
- Taille et poids avant grossesse

EXAMEN OBSTETRICAL

1. Objectif

Connaître le déroulement d'un examen obstétrical de routine

2. Signes vitaux

- TA, pulsation
- Température si signes d'appel
- Fréquence respiratoire si nécessaire (+ saturation en O2)

3. Examen obstétrical

En décubitus dorsal, jambes allongées

- Hauteur utérine (symphyse – fond utérin, en cm)



- Manœuvre de Léopold (au 3^e trimestre) : pour connaître la présentation fœtale



- Palpation utérine à la recherche de CU

4. Examen général

- Auscultation cardio-pulmonaire : au 1^{er} contrôle puis selon les plaintes

- Examen abdominal selon les plaintes: auscultation, palpation abdominale, percussion des loges rénales
- Examen des membres inférieurs : oedèmes (préE), réflexes (préE), status variqueux, recherche de signes de TVP
- Examen des seins : en début de grossesse si facteur de risque et en pp

5. Examen gynécologique

Examen réalisé au 1^{er} contrôle puis si symptômes (saignements, pertes de liquide, ...)

En position gynécologique, fesses bien au bord de la chaise, jambes relâchées

- Inspection de la vulve, anus, introïtus:
 - Lésions vulvaires (condylomes, ulcères, kystes, vésicules, ...), cicatrices obstétricales, mutilations génitales
 - Distance ano-vulvaire
 - Inspection vulvaire lors d'efforts de poussées (prolapsus ?)
- Examen au speculum :
 - Inspection du col: taille, surface, ectropion, polype, saignement, écoulement cervical
 - Réalisation du frottis cervical (identification de la zone de jonction, frottis exo- et endocervical), de frottis bactériologiques et d'un examen direct des pertes vaginales
 - Inspection des culs de sacs vaginaux et de la paroi vaginale en retirant le speculum doucement et à demi ouvert: fistule, prolapsus, voussures, lésions, ...
- Toucher vaginal :
 - N'a pas besoin d'être réalisé au 1^{er} contrôle
 - A réaliser si suspicion de début de travail, après avoir exclu un placenta recouvrant ou bas-inséré

6. Examens complémentaires

- Stix urinaire :
 - Recherche de protéines et de glucose dans les urines
 - Réalisé à chaque contrôle
- Doptone :
 - = Auscultation des BCF
 - A chaque contrôle, dès 12 SA
- Poids maternel

- CTG (CardioTocoGramme) :
 - Enregistrement du rythme cardiaque fœtal et des contractions utérines sur 20 minutes minimum
 - Sur indications uniquement (par exemple : contrôle du bien-être fœtal lors de dépassement de terme, dès 34 SA lors de diabète insulino-requérant ou de grossesse multiple, ...)
 - Enregistrement sur papier, permettant d'analyser plusieurs éléments :
 - Le rythme de base : entre 120-160 bpm
 - La fluctuation du rythme de base : accélérations (15 bpm pendant minimum 15 sec) et microvariabilité du rythme de base (amplitude de 5-10 bpm)
 - La modification du rythme de base en fonction des contractions
 - L'activité utérine

